

	IMPRESIÓN DE HISTORIA CLÍNICA NEUROPSICOLOGÍA								
	Historia # 00009				Fecha De Impresión: 12-11-2025 11:35:30				
Datos Personales									
Nombre:	CAMILO ENRIQUE CARREÑO SAUCEDO			Sexo Biológ.:	H	F. Nacimiento:	2017-07-07	Edad	8 Años, 4 Meses, Y 5 Días
Identificación:	TI - 1066892645			Lateralidad:	Diestro	Estado Civil:	Soltero	Ocupación:	ESTUDIANTE
Correo Electrónico:	Masaum2@hotmail.Com.Co - 1066892645					Dirección:	Manzana 69 Casa 8b Urbanización María Paula 3		
Departamento:	CESAR			Municipio:	VALLEDUPAR		Zona:	Urbana	
Empresa:	Particular								
En Caso De Emergencia Llamar A:				MARYIS SAUCEDO - Parentesco (madre)					

Apertura Neuropsicología del 2025-08-08 19:47:15: 8 años, 4 meses, y 5 días

DATOS GENERALES

DX principal F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION
Código de consulta No se ha seleccionado un código de consulta
Motivo de consulta Madre refiere, “desde muy niño ha tenido pataletas, cuando va a estudiar es muy difícil, se le olvidan las cosas”. Madre refiere, “desde muy niño ha tenido pataletas, cuando va a estudiar es muy difícil, se le olvidan las cosas”.
Enfermedad actual Paciente con cuadro de evolución desde el grado transición caracterizado por hacer pataletas, berrinches todo lo quiero tirar y dañar, terquedad, fijaciones en algunos aspecto – poco flexible, se le olvida donde deja las cosas y lo que va hacer, se le debe dar varias veces las instrucciones, le cuesta prestar atención, poca motivación escolar, se queda en dictado, se cansa con facilidad, baja motivación escolar, se distrae con facilidad, lo sientas detrás por ser muy alto, prefiere hacer otra cosa que hacer las tareas, necesidad de apoyo y supervisión para hacer tareas, en ocasiones se levanta con pesadillas, eso sucede desde los tres años, ha disminuido pero aún persiste. Buen aprendizaje, esta aprendiendo a leer, lo hace bien aunque no fluido, en ocasiones se levanta del puesto, toma las cosas en ocasiones sin consentimiento, dislalia – rotacismo, en ocasiones cuando va a hablar se bloque como si fuera disfemico.

ANTECEDENTES

Médicos Personales

Quirúrgico NA	Traumáticos Ninguno
Medicación NA	Paraclínicos
Hospitalizaciones NA	Patología Ninguna
Tóxicos	

ANTECEDENTES

Prenatales

Edad De La Madre En El Embarazo NA	Enfermedades De La Madre No
Único Embarazo 2	El Embarazo Fue Controlado Por Atención Médica Si
Uso De Planificación En El Momento Del Embarazo Si	Estado De La Madre Durante El Embarazo

ANTECEDENTES

Natales

Tipo De Nacimiento Cesarea	Causa De La Cesárea NA
Uso De Maniobras De Reanimación No	Peso Al Nacer 3600
Talla Al Nacer 51	Llanto Al Nacer Si

ANTECEDENTES

Posnatales

Hospitalizaciones Recién Nacido NA	Desarrollo Psicomotor
--	------------------------------

ANTECEDENTES Desarrollo Psicomotor	
Control Cefálico 3	Rolado 3
Sedente Solo 6	Gateo 7
Bípodo Sin Ayuda 11	Marcha 12
Lenguaje Verbal 11	Lenguaje Verbal Fluido 24

ANTECEDENTES Médicos Familiares	
Depresión No Refiere	Ansiedad No Refiere
Demencia No Refiere	Alcoholismo No Refiere
Drogadicción No Refiere	Discapacidad Intelectual No Refiere
Patológicos NO REPORTA	Otros

Áreas de Ajuste y/o Desempeño

Historia educativa Paciente quien cursa segundo grado, ocupó el puesto 12 de un total de 34, quejas escolares por ser distraído, tardaba mucho o se quedaba para la escritura - dictado, tiene un grupo con el que interactúa por el cual se desconcentra, se levanta del puesto de trabajo en algunas ocasiones.
Historia laboral
Historia familiar NA
Historia social NA

Historia socio-afectiva Inicia, mantiene y finaliza una interacción con otros. (si) Reconoce sentimientos. (si) Regular su propia conducta. (no) Controla sus impulsos. (no) Hace y mantiene relaciones de amistad y amor. (si) Se comporta en público de manera socialmente aceptable. (si) Termina las actividades que inicia. (si) Acepta los límites del adulto. (si) Cumple con normas de cortesía: por favor, gracias, permiso (si) Resuelve problemas y situaciones cotidianas. (si) Respeta los reglamentos deportivos y recreativos (si) Realiza trabajos sin depender de otros. (si)
--

Interconsultas e Intervenciones
Intervención psiquiátrica NA
Intervención neurológica NA
Intervención neuropsicológica NA

EXAMEN MENTAL
Examen Mental Paciente con adecuada presentación personal, alerta, adecuada higiene postural, orientado alo y auto psíquicamente, taquilalia, taquipsiquia, logorrea, distractico, no alteraciones de sueño, no alteraciones o quejas de memoria, no alteración en juicio y raciocinio, inteligencia aparentemente normal, no alucinaciones, no alteraciones de la conación.
Ciclos del Sueño Normal
Apetito Adecuado
Actividades de Autocuidado Funcionales

IMPRESIÓN DIAGNOSTICA

Impresión Diagnóstica (CIE 10 - DSM-V):
F900 - PERTURBACION DE LA ACTIVIDAD Y DE LA ATENCION

Establecido por primera vez

PLAN DE INTERVENCIÓN

Plan de Intervención

Objetivo General

Rehabilitación neuropsicológica 2 veces por semanas por seis meses que permita fortalecer los procesos cognitivos de atención sostenida, selectiva, mantenimiento en la tarea, motivación, metacognición, habilidades viso espaciales, fluidez fonológica, aprendizaje, velocidad de procesamiento, funciones ejecutivas, aprendizaje, praxias.

Rehabilitación dos veces por semana por seis meses desde psicología que permita abordar seguridad, confianza, tono de voz, organización, desarrollar habilidades en la resolución de problemas, desarrollo de asertividad; habilidades de afrontamiento; autocontrol y control emocional; (pataletas), entrenamiento en habilidades sociales.

Vincular a los padres mediante psicoeducación y sensibilización, como acompañamiento de la menor en sus dificultades, y orientarla en el manejo de estas.

Realizar actividad física o musical que permita mejorar los procesos de biorritmo y habilidades sociales.

Objetivos Especificos
NA

Sugerencias e Interconsultas

Observaciones y Recomendaciones

Realizar adecuación y adaptación curricular: Implementación del plan Individual de apoyos y ajustes razonables (PIAR) [Subsección 3 Esquema de atención educativa - Artículo 2.3.3.5.2.3.5], por parte de la institución educativa, que permita favorecer el proceso de avance del - la niña(o) en sus aprendizajes escolares, y fomentar la motivación hacia los mismos. Lo anterior implica ajustar los logros y competencias al nivel del - la niña(o), estableciendo metas a corto, mediano y largo plazo en el transcurso del grado escolar que curse y mecanismos que permitan potencializar los aprendizajes mediante diferentes estrategias de evaluación de contenidos y logros acordes a sus capacidades y no las del grupo exclusivamente.

Dar un trato digno.

Tener en cuenta que algunas respuestas pueden carecer de consistencia sobre todo las que se tratan de definir conceptos.

Permítale recuperar los exámenes con talleres o repitiendo exámenes, en caso de ser necesario.

Organización del espacio y materiales: Mantén tu escritorio ordenado y con los materiales necesarios a mano para evitar distracciones y facilitar el enfoque en las tareas.

Rutinas claras: Sigue una rutina diaria establecida, con instrucciones claras y pasos específicos para cada actividad, lo que ayuda a reducir la confusión y mejorar la atención.

Tiempos de descanso: Toma pequeños descansos entre tareas para recargar la atención. Puedes usar técnicas como la técnica Pomodoro (trabajar 25 minutos y descansar 5).

Tareas cortas y específicas: Divide las tareas grandes en partes más pequeñas y manejables, para que sea más fácil concentrarse en una cosa a la vez.

Uso de apoyos visuales: Utiliza agendas, listas de verificación, esquemas o dibujos para seguir instrucciones y mantenerse enfocado en lo que hay que hacer.

Minimizar distracciones: Busca un lugar tranquilo en el aula, si es posible, y reduce ruidos o estímulos que puedan distraer.

Técnicas de concentración: Practica ejercicios de respiración, mindfulness o atención plena para mejorar la capacidad de mantener la concentración.

Refuerzo positivo: Reconoce y celebra los esfuerzos y logros, por pequeños que sean, para motivar la atención y el interés en las tareas.

Comunicación con docentes: Mantén una comunicación abierta con los maestros para ajustar estrategias y recibir apoyo adicional cuando sea necesario.

Apoyo emocional: Fomenta la confianza y la paciencia, recordándole que mejorar la atención lleva tiempo y esfuerzo, y que está haciendo un buen trabajo.


Jainer E. Guzmán Vega
Psicólogo - M.G Neuropsicología
T.P 123096
U.S.B. - Medellín

DR. JAINER GUZMAN

Tarjeta Profesional: 123096